



**FACULDADE FAIPE
PÓS-GRADUAÇÃO EM PERIODONTIA**

EDNA LOPES DE CARVALHO

**A INFLUÊNCIA DO TABAGISMO NA PROGRESSÃO DA DOENÇA
PERIODONTAL**

Belo Horizonte
2025

EDNA LOPES DE CARVALHO

**A INFLUÊNCIA DO TABAGISMO NA PROGRESSÃO DA DOENÇA
PERIODONTAL**

Monografia apresentada ao Instituto de
Ensino Superior – FAIPE, para obtenção
do título de Especialista em Periodontia.

Orientador: Prof. Jorge Antonio Mansur de
Miranda, Leonardo Silveira Damasceno e
Glácio Mauro Ribeiro Júnior.

Belo Horizonte
2025

EDNA LOPES DE CARVALHO

**A INFLUÊNCIA DO TABAGISMO NA PROGRESSÃO DA DOENÇA
PERIODONTAL**

Monografia apresentada ao Instituto de Ensino Superior – FAIPE, para obtenção do título de Especialista em Periodontia.

Banca examinadora

Prof. ^a

Membro
Prof.

Membro
Prof.

Data: ____/____/____

Nota: _____

RESUMO

A presente pesquisa é uma revisão bibliográfica da literatura científica sobre a influência do tabagismo na progressão da doença periodontal. O objetivo deste estudo foi compreender os efeitos do uso do tabaco sobre os tecidos periodontais, avaliando suas implicações na etiologia, evolução e resposta ao tratamento da periodontite em indivíduos fumantes. Para a realização deste trabalho, foram utilizados artigos científicos relacionados à saúde bucal, imunologia, microbiologia oral, efeitos da nicotina e práticas odontológicas em pacientes tabagistas. A análise permitiu identificar que o tabagismo interfere negativamente na vascularização, no equilíbrio da microbiota oral, na resposta imune e na eficácia dos tratamentos periodontais. Constatou-se também que o hábito de fumar está associado a maior risco de perda óssea, falhas terapêuticas e evolução mais agressiva da doença periodontal. Com base nos dados apresentados, conclui-se que a cessação do tabagismo, aliada a medidas preventivas e acompanhamento odontológico regular, é fundamental para o sucesso do tratamento periodontal e para a promoção da saúde bucal integral.

Palavras-chave: Tabagismo. Doença Periodontal. Saúde Bucal. Cigarro.

ABSTRACT

This research is a bibliographic review of the scientific literature on the influence of smoking on the progression of periodontal disease. The objective of this study was to understand the effects of tobacco use on periodontal tissues, evaluating its implications on the etiology, evolution and response to treatment of periodontitis in smokers. To carry out this work, scientific articles related to oral health, immunology, oral microbiology, effects of nicotine and dental practices in smoking patients were used. The analysis allowed us to identify that smoking negatively interferes with vascularization, the balance of the oral microbiota, the immune response and the effectiveness of periodontal treatments. It was also found that the habit of smoking is associated with a greater risk of bone loss, therapeutic failures and more aggressive progression of periodontal disease. Based on the data presented, it is concluded that smoking cessation, combined with preventive measures and regular dental follow-up, is essential for the success of periodontal treatment and for the promotion of comprehensive oral health.

Keywords: Smoking. Periodontal Disease. Oral Health. Cigarette.

LISTA DE QUADROS

Quadro 1 - Nova classificação da periodontite: Estágios e Graus.....	12
--	----

LISTA DE FIGURAS

Figura 1 - Progressão da gengivite para periodontite.....	11
---	----

SUMÁRIO

1 INTRODUÇÃO	8
2 DESENVOLVIMENTO.....	10
2.1 SAÚDE E DOENÇA PERIODONTAL	10
2.2 TABAGISMO	13
2.3 TABAGISMO CORRELACIONADO À DOENÇA PERIODONTAL	15
2.4 TRATAMENTO ODONTOLÓGICO PARA DOENÇAS GENGIVAIS DECORRENTE DO USO DO TABACO	16
3 CONCLUSÃO.....	18
REFERÊNCIAS	19

1 INTRODUÇÃO

O tabagismo é considerado uma das principais causas evitáveis de adoecimento e morte no mundo. Trata-se de um problema de saúde pública global, cuja prática afeta diretamente diversos sistemas do organismo humano, incluindo o sistema respiratório, cardiovascular e, de forma bastante significativa, a saúde bucal. O uso contínuo de produtos derivados do tabaco, como cigarros, charutos e tabaco para narguilé, está associado a inúmeras complicações bucais, muitas das quais são pouco valorizadas pelos usuários. No Brasil, de acordo com a Pesquisa Nacional de Saúde (PNS) de 2019, cerca de 12,6% da população adulta afirmava ser fumante; um dado que representa mais de 20 milhões de pessoas expostas aos efeitos nocivos do tabaco (Brasil, 2020).

Na cavidade bucal, o tabagismo tem um papel agressivo direto sobre os tecidos periodontais, comprometendo a gengiva, os ligamentos periodontais e o osso alveolar. A presença constante de substâncias tóxicas no ambiente bucal interfere nos mecanismos de defesa do organismo, reduzindo a vascularização local e dificultando a resposta imunológica frente a microrganismos patogênicos. Como resultado, os fumantes apresentam maior propensão ao desenvolvimento de doenças periodontais, com progressão mais rápida e tratamento menos eficaz do que em pacientes não fumantes (Medeiros; Dias, 2018).

Além dos danos nos tecidos de suporte dos dentes, o tabagismo também é responsável por alterações estéticas e funcionais perceptíveis, como o amarelamento dos dentes, provocado pela impregnação de nicotina e alcatrão no esmalte dentário. O mau hálito, outro sintoma recorrente entre fumantes, é causado tanto pela presença contínua de resíduos tóxicos quanto pela boca seca — consequência da redução do fluxo salivar. Essas condições, apesar de comumente vistas como apenas estéticas, têm impacto direto na qualidade de vida, autoestima e saúde geral dos indivíduos (Santos; Siqueira, 2016).

Estudos apontam que a relação entre o tabagismo e a doença periodontal é de natureza dose-dependente, ou seja, quanto maior o tempo e intensidade do hábito de fumar, maior a gravidade da doença, assim como num equação diretamente proporcional. Dados da literatura indicam que fumantes têm um risco de duas a sete vezes maior de desenvolver periodontite avançada quando comparados a não

fumantes. Além disso, estima-se que aproximadamente 42% dos casos de periodontite severa no mundo estejam relacionados ao consumo de tabaco (WHO, 2022). Entre as principais doenças associadas à saúde bucal do fumante estão gengivite, periodontite, leucoplasia, candidíase bucal, retração gengival e câncer de boca (Medeiros; Dias, 2018).

Neste contexto, justifica-se a importância de aprofundar o conhecimento sobre os impactos do tabagismo na saúde periodontal. Este trabalho tem relevância acadêmica, ao contribuir para a literatura da área de saúde bucal, especialmente nos cursos de Odontologia e afins/especializações, oferecendo subsídios para a formação de profissionais mais conscientes sobre os fatores agravantes da doença periodontal. Socialmente, a pesquisa se justifica por possibilitar a ampliação do debate público sobre os riscos do tabagismo, reforçando a necessidade de ações preventivas e campanhas de conscientização que integrem o cuidado com a saúde bucal aos demais aspectos da saúde geral. Ressalta-se ainda que o presente estudo não é uma repetição de abordagens anteriores, pois busca sistematizar informações atuais e acessíveis, podendo ser utilizado como artigo de consulta em ambientes acadêmicos e clínicos (Moura et al., 2016).

Dessa forma, torna-se fundamental investigar com maior profundidade a influência do tabagismo na progressão da doença periodontal, abordando os principais mecanismos fisiopatológicos envolvidos, bem como as consequências clínicas desse hábito nocivo sobre a cavidade oral. Ao reunir dados científicos atualizados e analisar a associação entre o tabagismo e os agravos periodontais, este trabalho pretende contribuir para o fortalecimento de práticas educativas e de prevenção em saúde bucal (WHO, 2022).

Assim o propósito deste descrito fica estabelecido em discorrer acerca da influência do tabagismo na progressão da doença periodontal, destacando os principais mecanismos de impacto do tabaco sobre os tecidos periodontais e as consequências clínicas observadas em pacientes fumantes.

2 DESENVOLVIMENTO

2.1 SAÚDE E DOENÇA PERIODONTAL

A saúde periodontal é o reflexo de um equilíbrio dinâmico entre fatores imunológicos, anatômicos e microbiológicos na cavidade bucal. Quando esse equilíbrio está mantido, os tecidos periodontais (como gengiva, ligamento periodontal e osso alveolar) permanecem íntegros e funcionais, proporcionando sustentação adequada aos dentes e contribuindo para a estabilidade oclusal e estética oral (Teixeira et al., 2018; Almeida et al., 2019).

Gengivas saudáveis possuem coloração rosa-clara, textura firme e aspecto pontilhado, semelhante à casca de uma laranja. Elas se ajustam firmemente ao redor dos dentes e não apresentam sinais de inflamação, como vermelhidão, inchaço ou sangramento espontâneo. A ausência de sangramento à sondagem é considerada um dos principais indicadores clínicos de saúde periodontal. Em situações saudáveis, essas bolsas periodontais costumam ter entre 1 e 3 mm de profundidade, sem sangramento durante a avaliação (Teixeira et al., 2018).

Outro aspecto importante da saúde periodontal está relacionado à preservação das estruturas de suporte dos dentes. Isso implica na manutenção do ligamento periodontal e do osso alveolar, sem sinais de mobilidade dentária patológica ou reabsorção óssea progressiva. Além disso, a correta relação oclusal entre os dentes também contribui para a prevenção de sobrecargas funcionais que possam desencadear alterações periodontais (Almeida et al., 2019).

No que diz respeito à microbiota bucal, o estado de eubiose (ou seja, o equilíbrio entre microrganismos benéficos e potencialmente patogênicos) é essencial para a manutenção da integridade dos tecidos periodontais. Bactérias como *Streptococcus sanguinis*, *Streptococcus mitis*, *Streptococcus salivarius* e *Streptococcus gordonii* são comuns em bocas saudáveis e têm papel protetor, seja inibindo a adesão de patógenos ou regulando o pH bucal de forma a dificultar a colonização de bactérias nocivas. Já espécies como *Actinomyces naeslundii* e *Actinomyces oris* contribuem para o metabolismo dos carboidratos e para a estabilidade do biofilme dentário (Gupta et al., 2022). Contudo, existem fatores que

podem romper essa homeostase e favorecer o desenvolvimento de doenças periodontais (Angst et al., 2015).

As doenças periodontais são condições inflamatórias de origem infecciosa que comprometem os tecidos periodontais. A forma mais leve ou inicial é a gengivite, caracterizada por inflamação localizada da gengiva, com sintomas como vermelhidão, edema e sangramento durante a escovação ou sondagem. A gengivite é reversível quando tratada adequadamente, mas, se negligenciada, pode evoluir para periodontite, que é uma condição mais grave, que envolve a destruição do tecido conjuntivo além de perda óssea ao redor dos dentes (Figura 1) (Armitage, 1999; Prado; Souza, 2024).

Figura 1 - Progressão da gengivite para periodontite.



Fonte: Costa et al. (2022)

Estudos recentes confirmam que a etiologia da doença periodontal é multifatorial, mas é unânime entre estudiosos e profissionais da área que o biofilme bacteriano é o agente inicial (Bagaitkar et al., 2011). Contudo, o desenvolvimento e a progressão da doença são influenciados por determinados fatores, como o uso do tabaco, por exemplo (Gupta et al., 2022).

Atualmente, a classificação da doença periodontal foi substituída por aquela que as classificava como periodontite agressiva (AgP), periodontite crônica (PC) e periodontite como uma manifestação de doenças sistêmicas (Armitage, 1999; Borojevic, 2012).

Em 2017, foi publicada uma nova classificação elaborada pela Federação Europeia de Periodontologia (EFP) em parceria com a Academia Americana de

Periodontologia (AAP), que aboliu os termos periodontite crônica e agressiva e passou a categorizar a periodontite em estágios (de I a IV) e graus (de A a C), com base na severidade, complexidade e risco de progressão (Papapanou et al., 2018).

Dessa forma, recomenda-se o uso dessa classificação mais recente nos estudos atuais, visto que reflete melhor o conhecimento contemporâneo da doença periodontal (Quadro 1).

Quadro 1 - Nova classificação da periodontite: Estágios e Graus

Dimensão	Categoria	Crítérios principais
Estágio (<i>severidade e complexidade</i>)	Estágio I (Inicial)	- Perda de inserção clínica $\leq$ 1–2 mm - Perda óssea limitada (máx. 15%) - Sem perda dentária por periodontite - <i>Probing</i>¹ $\leq$ 4 mm
	Estágio II (Moderada)	- Perda de inserção clínica $\leq$ 3–4 mm - Perda óssea entre 15 e 33% - Ausência de perda dentária - <i>Probing</i> $\leq$ 5 mm
	Estágio III (Avançada com potencial de perda de dente)	- Perda de inserção $\geq$ 5 mm - Perda óssea além de 33% - Perda de até 4 dentes por periodontite - <i>Probing</i> $\geq$ 6 mm; - envolvimento de furca

¹ O termo "probing" vem do inglês e refere-se à sondagem periodontal. Em português técnico, denomina-se como sondagem periodontal. As medidas normais variam entre 1 e 3 mm. Nos casos de profundidades maiores, pode haver indicação de gengivite ou periodontite, dependendo de outros sinais clínicos. Então, no Quadro 1 ao aparecer "Probing", pode-se entender como: profundidade de sondagem periodontal

	Estágio IV (Avançada com perda de função dentária)	- Perda extensa de inserção - Perda de 5 ou mais dentes por periodontite - Mobilidade dentária severa - Necessidade de reabilitação complexa
Grau (<i>progressão da doença e risco futuro</i>)	Grau A (Progressão lenta)	- Evidência indireta de progressão lenta - Sem histórico de perda rápida - Sem fator de risco modificável significativo
	Grau B (Progressão moderada)	- Perda de inserção proporcional à idade - Evidência de progressão moderada - Fumante <10 cigarros/dia ou diabético bem controlado
	Grau C (Progressão rápida)	- Perda de inserção desproporcional à idade - Evidência de progressão acelerada - Fumante ≥10 cigarros/dia ou diabético mal controlado

Fonte: Papapanou et al. (2018); Tonetti et al. (2018) – Adaptado.

2.2 TABAGISMO

O tabagismo configura-se como um dos mais relevantes desafios à saúde pública mundial. O uso de produtos derivados do tabaco, como cigarros, narguilés e charutos, está associado a inúmeras doenças crônicas, incluindo enfermidades cardiovasculares, respiratórias, gastrointestinais e diversas alterações na cavidade bucal (Pintado, 2010). Estima-se que o cigarro contenha mais de 4.000 substâncias

químicas, muitas delas com elevado grau de toxicidade e potencial cancerígeno. Entre os principais componentes estão a nicotina, responsável pela dependência química, e o alcatrão (subproduto da combustão do cigarro), que contribui para manchas dentárias e mau hálito (Boscolo et al., 2019; Santos, 2021).

Do ponto de vista bucal, o consumo de tabaco está diretamente relacionado a uma série de agravos, como a doença periodontal, o câncer de boca, o mau hálito, a pigmentação dental, além da diminuição do paladar e do olfato (Torres et al., 2019; Castro et al., 2021). A ação do tabaco sobre os tecidos da cavidade oral é influenciada pelo tempo de uso, pela quantidade de cigarros consumidos diariamente e pela resposta imunológica individual. Em fumantes crônicos, observa-se maior comprometimento do periodonto, o que se traduz em um risco até três vezes maior para o desenvolvimento de periodontite, quando comparado a não fumantes (Pereira, 2021).

A nicotina, ao ser inalada, é rapidamente absorvida pelos pulmões e distribuída pela corrente sanguínea, atingindo o cérebro em poucos segundos (estima-se que seja entre 9 e 17 segundos). Ela induz a liberação de dopamina, o que gera sensação de prazer, reforçando o vício. Além disso, sua presença em altas concentrações na saliva e no fluido gengival está associada a alterações celulares importantes, como toxicidade tecidual, retardo na cicatrização e estímulo à degradação dos tecidos periodontais (INCA, 2022; Boscolo et al., 2019).

Entre os efeitos fisiológicos mais nocivos da nicotina está a vasoconstrição, que reduz o fluxo sanguíneo local. Com isso, há uma diminuição na oxigenação dos tecidos, comprometendo a resposta inflamatória e dificultando o processo de regeneração óssea, já que esse processo depende de uma boa vascularização, que se dá através do sangue onde são transportadas células reparadoras, nutrientes e fatores de crescimento necessários para a reconstrução dos tecidos periodontais. (Pintado, 2010).

Destaca-se ainda que essa alteração também mascara sinais clínicos da doença periodontal, como o sangramento gengival, dificultando o diagnóstico precoce. Fumantes frequentemente apresentam gengivas mais pálidas e aparentemente sem inflamação, mesmo diante de um quadro avançado de comprometimento periodontal (Alves; Lira; Pachu, 2021; Malta, 2021).

Além da nicotina, o alcatrão exerce efeito estético e fisiológico considerável. Ele se adere ao esmalte dentário, causando manchas amareladas e escurecidas, e favorece o desenvolvimento do mau hálito, uma vez que reduz a produção salivar, contribuindo para o ressecamento da mucosa oral e alteração do equilíbrio microbiológico (Bertoni; Szklo, 2021; CRO-PR, 2020).

2.3 TABAGISMO CORRELACIONADO À DOENÇA PERIODONTAL

A associação entre tabagismo e doença periodontal é conhecida desde a década de 1970, quando se observou que fumantes apresentavam maior prevalência de alterações periodontais, independentemente de sua higiene bucal – quando comparados a indivíduos não fumantes (Pintado, 2010). Desde então, os estudos têm confirmado que o uso do tabaco é um fator de risco significativo e modificável para o desenvolvimento e progressão da doença periodontal (Costa et al., 2022).

A literatura constata que o tabagismo interfere negativamente na resposta imunológica do organismo, afetando diretamente a vascularização dos tecidos periodontais, como já dito. Destaca-se que a nicotina provoca vasoconstrição, diminuindo o fluxo sanguíneo gengival e dificultando a oxigenação e a nutrição dos tecidos, o que leva à isquemia local. Esse processo contribui para a destruição das estruturas de suporte dos dentes, mesmo em indivíduos que mantêm controle adequado da placa bacteriana (Bernardes; Ferres; Júnior, 2013). Além disso, a redução da vascularização compromete a reparação tecidual e retarda a cicatrização após procedimentos periodontais (Oliveira; Fernandes; Stefani, 2016).

Acrescido, Coretti et al. (2017) ainda menciona que fumantes têm de 2 a 8 vezes mais risco de sofrer perda óssea e perda de inserção periodontal quando comparados a não fumantes. Além disso, fumantes apresentam piores desfechos clínicos em todas as modalidades de tratamento periodontal.

No nível celular, o tabaco compromete mecanismos importantes da defesa do hospedeiro, como a quimiotaxia e a atividade fagocitária dos leucócitos polimorfonucleares, além de diminuir a produção de anticorpos como a imunoglobulina G (IgG), que é essencial no combate a microrganismos patogênicos (Kenney et al., 1997; Pacheco; Vinhas, 2008). Acrescido, o uso prolongado de tabaco também reduz

a capacidade de proliferação das células T e afeta a função das células B, prejudicando a resposta imune adaptativa.

Entre os sinais clínicos da periodontite associada ao tabagismo destacam-se: aumento da profundidade das bolsas periodontais, perda de inserção clínica, presença de cálculo subgengival e nos casos mais graves perda dentária (Santos; Siqueira, 2016).

Segundo Aquino et al. (2010), a destruição tecidual observada em fumantes com periodontite está relacionada à interação entre microrganismos patogênicos e uma resposta imune comprometida, marcada pela atuação prejudicada dos monócitos e linfócitos.

O hábito de fumar afeta também a microbiota bucal, contribuindo para alterações qualitativas e quantitativas na composição do biofilme dental. Um exemplo é a liberação de cotinina, metabólito da nicotina detectado em saliva e fluido gengival, o qual está associado ao agravamento das lesões periodontais (Bernardes; Ferres; Júnior, 2013). Nesse caso, pontua-se que tais alterações dificultam a regeneração dos tecidos e contribuem para o fracasso terapêutico em procedimentos periodontais, como raspagens, cirurgias regenerativas e também implantes (Dias, 2015).

Embora se reconheça a influência de múltiplas toxinas presentes no cigarro sobre os tecidos periodontais, ainda há necessidade de estudos mais aprofundados para identificar, de forma específica, quais componentes exercem maior e menor impacto nas alterações clínicas observadas (Dias, 2015).

2.4 TRATAMENTO ODONTOLÓGICO PARA DOENÇAS GENGIVAIS DECORRENTE DO USO DO TABACO

A exposição contínua às substâncias presentes no cigarro, especialmente a nicotina, provoca alterações significativas nos tecidos bucais. De rápida absorção pelo epitélio da mucosa oral e até mesmo pela superfície dentária, a nicotina exerce efeitos tóxicos que comprometem a função celular, dificultando a regeneração tecidual e agravando quadros inflamatórios gengivais (Carvalho, 2018).

No contexto do tratamento periodontal, indivíduos tabagistas costumam apresentar respostas menos satisfatórias, principalmente em procedimentos

regenerativos. As toxinas oriundas da fumaça do cigarro interferem na função de fibroblastos, osteoblastos e outras células essenciais ao processo de reparação, retardando a cicatrização e reduzindo a eficácia de terapias como enxertos ósseos e regeneração guiada (Pinto; Barbosa, 2021; Rocha, 2019).

A abordagem clínica nesses casos deve ser ampla, envolvendo desde medidas preventivas — como instrução de higiene bucal com escovação adequada, uso correto do fio dental e antissépticos bucais — até terapias de raspagem e alisamento radicular, controle químico da placa bacteriana com antimicrobianos e, quando necessário, intervenções cirúrgicas (Santos, 2021; Faria, 2020).

Um passo essencial no êxito do tratamento é a cessação do tabagismo. Estudos demonstram que a interrupção do hábito tabágico favorece a reversão da inflamação gengival, melhora a resposta imune local e aumenta significativamente o sucesso dos procedimentos periodontais. Por isso, a reabilitação do paciente deve incluir aconselhamento sobre abandono do fumo, suporte psicológico e acompanhamento multidisciplinar, quando possível (Ferreira et al., 2019; Castro et al., 2021).

O acompanhamento periódico é indispensável para pacientes tabagistas ou ex-tabagistas. Recomenda-se consultas de manutenção a cada três meses para controle da placa bacteriana e detecção precoce de recidivas. Essa estratégia permite preservar os tecidos de suporte e minimizar os efeitos deletérios deixados pelo tabaco na cavidade oral (Serqueira, 2019; Brito, 2018).

3 CONCLUSÃO

A influência do tabagismo na progressão da doença periodontal é um tema de alta relevância clínica, acadêmica e social. Ao longo deste trabalho, foi possível constatar que o uso contínuo do tabaco compromete diretamente a saúde bucal, afetando os tecidos de suporte dos dentes, alterando a resposta imunológica, interferindo na microbiota oral e dificultando a cicatrização dos tecidos periodontais. No decorrer do trabalho nota-se que diversos autores evidenciam que o tabaco não apenas potencializa os danos causados pela placa bacteriana, mas também dificulta o sucesso terapêutico, tornando a periodontite mais agressiva e de difícil controle em pacientes fumantes.

Além disso, ficou claro que o tabagismo afeta negativamente os mecanismos de defesa do organismo, reduzindo a eficácia da resposta inflamatória, a produção de anticorpos e a ação das células de defesa. Isso torna o fumante mais vulnerável ao avanço da doença periodontal e às falhas nos tratamentos odontológicos convencionais.

No âmbito terapêutico, a literatura consultada reforça que a cessação do tabagismo deve ser incentivada como parte essencial do plano de tratamento. A interrupção do hábito proporciona melhor prognóstico clínico, favorece a resposta à terapia periodontal e colabora para a recuperação da integridade tecidual. Medidas como a educação em saúde bucal, o controle rigoroso da placa, o acompanhamento periódico e o aconselhamento sobre abandono do cigarro são fundamentais para o sucesso da abordagem clínica.

Portanto, conclui-se que o tabagismo é um fator de risco determinante na instalação, progressão e resistência ao tratamento da doença periodontal. O enfrentamento dessa condição exige uma atuação integrada entre profissionais da saúde bucal, estratégias educativas e o engajamento do paciente em mudanças comportamentais. Dessa forma, a abordagem odontológica deve ser não apenas clínica, mas também preventiva, educativa e humanizada, promovendo não apenas a saúde bucal, mas o bem-estar geral do indivíduo.

REFERÊNCIAS

ALMEIDA, J. R. S.; LIMA, M. C. F.; CASTRO, C.; PRAXEDES, C. E. S.; AMARAL, M. E. S.; SOUSA, R. M. R. B. Espaço de promoção da saúde na graduação em Odontologia; (re)significando saberes e práticas na produção do cuidado. **Revista Associação Brasileira de Ensino Odontológico**, v.19, n. 2, p 127-134, 2019.

ALVES, T.; et al. Aspectos biopsicossociais relacionados ao consumo de tabaco entre universitários: Uma revisão integrativa. **Research, Society and Development**, v. 10, n. 7, e11210716250-, 2021.

ANGST, P. D. M.; GOMES, S. C.; OPPERMAN, R. V. Do controle de placa ao controle do biofilme supragengival: o que aprendemos ao longo dos anos?. **Revista da Associação Paulista de Cirurgiões Dentistas**, v.69, n. 3, p. 252-9, 2015.

AQUINO, D. R.; FRANCO, G. C. N.; CORTELLI, J. R.; QUEIROZ, A. P. G.; CORTELLI, J. G.; Prevalência de patógenos periodontais em tabagistas. **Revista Periodontia**, v. 20, p. 67-72, 2010.

ARMITAGE, G. C. Development of a classification system for periodontal diseases and conditions. **Annals of Periodontology**, v. 4, n. 1, p. 1–6, 1999.

BAGAITKAR, J.; DAEP, C.A.; PATEL, C.K.; RENAUD, D.E.; DEMUTH, D.R.; SCOTT, DA. A fumaça do tabaco aumenta a formação de biofilme de *Porphyromonas gingivalis*-*Streptococcus gordonii*. **PLoS Um**, v. 6, n. 11, e27386, 2011.

BERNARDES, V. S.; FERRES, M. O.; JÚNIOR, W. L.; O tabagismo e as doenças periodontais. **Revisão de Literatura - FOL - Faculdade de Odontologia de Lins/Unimep.**, v. 23, p. 37-45, 2013.

BERTONI, N.; et al. Dispositivos eletrônicos para fumar nas capitais brasileiras: prevalência, perfil de uso e implicações para a Política Nacional de Controle do Tabaco. **Cadernos de Saúde Pública**, v. 1, n. 37, e00261920, 2021.

BOROJEVIC, T. Tabagismo e doença periodontal. **Matéria Sociomédica**, v. 24, n. 4, p. 274–276, 2012.

BOSOCOLO, C.C.; et al. **Atuação do projeto de extensão promoção da saúde bucal e fonoaudiológica no combate ao tabagismo junto à unidade básica de saúde ramos.** 2019. Disponível em: <https://repositorio.ufsc.br/bitstream/handle/123456789/199294/UFCSPA%20-%20Atua%C3%A7%C3%A3o%20do%20Projeto%20de%20Extens%C3%A3o%20Promo%C3%A7%C3%A3o%20da%20sa%C3%BAde%20Bucal%20e%20Fonoaudiol%C3%B3gica%20no%20Combate%20ao%20Tabagismo%20junto%20%C3%A0%20Unidade%20B%C3%A1sica%20de%20Sa%C3%BAde%20Ramos.pdf?sequence=1>. Acesso em 24 jun. 2025.

BRASIL. Ministério da Saúde. **Pesquisa Nacional de Saúde 2019:** percepção do estado de saúde, estilos de vida, doenças crônicas e saúde bucal. IBGE, 2020. Disponível em: <https://www.ibge.gov.br>. Acesso em: 09 jun. 2025.

BRITO, R. F. **Promoção da saúde bucal e fonoaudiológica no combate ao tabagismo.** Porto Alegre, RS. Caderno de resumos. Porto Alegre: UFRGS/Prorext, 20 f, 2019.

CARVALHO, A. E.; SANTOS, I. G.; CURY, F. V.; A influência do tabagismo na doença periodontal: revisão de literatura. **Sotau: revista virtual de Odontologia**, v.5, p.7-12, 2008.

CASTRO, J. R. T.; et al. O Tabagismo como Fator de Risco para o Câncer Bucal: Principais Evidências e Tendências. **Ensaio e Ciência C Biológicas Agrárias e da Saúde**, v. 25, n. 5, p. 724-728, 2021.

CASTRO, J. R. T.; et al. O Tabagismo como Fator de Risco para o Câncer Bucal: Principais Evidências e Tendências. **Ensaio e Ciência C Biológicas Agrárias e da Saúde**, v. 25, n. 5, p. 724-728, 2021.

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO PARANÁ – CRO-PR. **O uso habitual de produtos de tabaco e sua influência nas doenças periodontais, doenças perimplantares e implantes dentários**. Curitiba – Paraná, 2020.

COSTA, C.M.S.; et al. A relação das substâncias do tabaco na doença periodontal. **Research, Society and Development**, v. 11, n. 16, e223111638279, 2022.

DIAS, F. F. C. Tabagismo como fator de risco para doença periodontal. Biblioteca da Faculdade de Odontologia de Piracicaba/ UNICAMP, p. 26, 2015.

FERREIRA, G. J., et al. (2019). O tabagismo e a doença periodontal: revisão de literatura. **Contribuições científica em odontologia: pessoas, práticas e novos paradigmas**, v. 12, n. 3, p. 246-261, 2019.

GUPTA, V.; VERMA, S. K.; SINGH, P.; ALAM, M. S.; GUPTA, B.; KUMARI, P. Oral Hygiene Practices and the Awareness of Perio-Systemic Interrelationship Among the Population of Ranchi City: A Hospital-Based Study. **Cureus Journal of Medical Science**, p. 1-10, 2022.

INSTITUTO NACIONAL DE CÂNCER - INCA. **Tabagismo passivo**. 2022. Disponível em: <https://www.gov.br/inca/pt-br/assuntos/causas-e-prevencao-docancer/tabagismo/tabagismopassivo#:~:text=A%20fuma%C3%A7a%20%C3%A9%20uma%20mistura,particulada%20cont%C3%A9m%20nicotina%20e%20alcatraz%3A3o..> Acesso em 24 jun. 2025.

KENNEY, E. B.; KRAAL, J. H.; SAXE, S. R.; JONES, J.; The effect of cigarette smoke on human oral polymorphonuclear leukocytes. **Journal Periodontal Research**, v.12, p. 227-234, 1997.

MALTA, D. C.; et al. Uso, cessação, fumo passivo e exposição à mídia do tabaco no Brasil: resultados das Pesquisas Nacionais de Saúde 2013 e 2019. **Revista Brasileira de Epidemiologia**, v. 1, n. 24, p. 1-9, 2021.

MEDEIROS, G.V.P.; DIAS, K.S.P.A. A influência do tabagismo na doença periodontal: Uma Revisão de Literatura. **ID on line. Revista de psicologia**, [S. l.], v. 12, n. 40, p. 470–479, 2018.

MOURA, S.K.; et al. Influência do Hábito de Fumar na Prevalência da Doença Periodontal em Idosos do Município de Londrina, **Pruniciências**, v. 20, n. 1, p. 62-7, 2016.

OLIVEIRA, D. M. S. L.; FERNANDES, A. U. R.; STEFANI, C. M.; Relação entre tabagismo e risco genético às doenças periodontais. **Sobrape**. v. 26, p. 34-39, 2016.

PACHECO, J. J; VINHAS, A. S.; Tabaco e doenças periodontais. **Revista Portuguesa de Estomatologia, Medicina Dentária e Cirurgia Maxilofacial**, v.49, p. 39-45, 2008.

PAPAPANOU, P. N.; et al. Periodontitis: Consensus report of workgroup 2 of the 2017 World Workshop on the Classification of Periodontal and Peri-Implant Diseases and Conditions. **Journal of periodontology**, v. 89, n. 1, p. 173-182, 2018.

PEREIRA, M. I. R.; et al. Ser ou não ser Fumante: uma Análise da Percepção dos Consumidores de Tabaco sobre os Impactos Fisiológicos e Sociais de seu Uso. **Revista Horizontes Interdisciplinares da Gestão**, v. 5, n. 2, p. 121-140, 2021.

PINTADO, C. H. A influência do tabaco na patologia periodontal. **Faculdade De Medicina Dentária Da Universidade Do Porto**, p.10-12, 2010.

PINTO, G. A. D. F.; et al. Câncer Bucal X Doença Periodontal. **Anima Educação**, v. 22, n. 16, p. 111-123, 2021.

PRADO, K. G.; SOUZA, E. B. Doença periodontal: uma revisão sobre os principais fatores de risco e tratamentos. *Cadernos UniFOA*, v. 19, n. 54, p. 1-9, mai./set.,2024.

ROCHA, E. F. O cigarro, o narguilé e a doença periodontal. **Revista Eletrônica Acervo Saúde**, v. 28, n. 1, e784-e784, 2019.

SANTOS, E. S.; et al. Análise do perfil epidemiológico em saúde Bucal de regiões distintas do Município de Penedo–AL: Estratégia de fortalecimento e redirecionamento da política de saúde bucal. **Research, Society and Development**, v. 10, n. 6, e42110615368, 2021.

SANTOS, V. T. A.; SIQUEIRA, L. C. B.; Tabaco e doenças periodontais. **Revista Científica multidisciplinar UNIFLU**, v. 1, p. 29-37, 2016.

SANTOS, V.; SIQUEIRA, L.C. Tabaco e Doenças Periodontais. **Rev. Cient.In FOC**, v. 1, n. 1, p. 89-98, 2016.

TEIXEIRA, F. C. F.; LEÓN, L. M.; GOMES, E. P.; PEDRÃO, A. M. N.; PEREIRA, A. C.; FRANCISCO, P. M. S. B. Perda de inserção periodontal e associações com indicadores de risco sociodemográficos e comportamentais. **Revista de Odontologia da UNESP**, v. 48, p. 1-11, 2018.

TONETTI, M. S., GREENWELL, H., KORNMAN, K. S. Staging and grading of periodontitis: Framework and proposal of a new classification and case definition. **Journal of periodontology**, v. 89, n. 1, p. 159-172, 2018.

TORRES, L. M. M.; et al. Relação do tabagismo com o surgimento do câncer na cavidade bucal: Uma Revisão de Literatura. **SEMPESq-Semana de Pesquisa da Unit-Alagoas**, v. 7, s.n., p. 1-8, 2019.

WORLD HEALTH ORGANIZATION (WHO). **Global Oral Health Status Report: Towards Universal Health Coverage for Oral Health by 2030**. Geneva: WHO, 2022.

Disponível em: <https://www.who.int/publications/i/item/9789240061484>. Acesso em: 09 jun. 2025